Henvisning og booking ECT

Lægernes arbejdsgang ifm. henvisning til ECT

1. Informeret samtykke:

- Forud for behandling skal den henvisende læge orientere patienten og de pårørende om behandlingens formål, teknik, effekt og bivirkninger.
- Patienten skal også have udleveret den fællespsykiatriske patientvejledning "Behandling med ECT".

2. Forundersøgelser:

- Somatisk undersøgelse, inklusiv hjerte-lungestetoskopi
- Blodprøve (ECT-blodprøvepakke jf. Blodprøveprofiler i Psykiatrien, fællespsykiatrisk retningslinje). Andre blodprøver kan være relevante i forbindelse med somatisk sygdom f.eks. INR (se ECT-vejledning - afsnit 5) (Opstart af ECT-serie: maks. 1 uge gammel; v-ECT: hver 3.mdr)
- EKG (Opstart af ECT-serie: maks. 1 uge gammel; v-ECT: hver 3.mdr)
- Røntgen af thorax – hos patienter med kardiopulmonale lidelser, hypertension eller med en alder over 70 år. Må være op til 6 måneder gamle, såfremt patienten ikke har nye symptomer
- Puls, blodtryk, vægt og BMI
- Tandstatus og evt. tandlægetilsyn
- Allergi (husk at opdatere CAVE)

3. Risikovurdering, kontraindikationer og risikofaktorer:

- Ved komplicerende somatiske lidelser (ECT-vejledning-afsnit 2.5) skal det være sikret, at patienten er optimalt behandlet ved at benytte relevante tilsyn (kardiolog, neurolog osv.), og dernæst anæstesilæge (ECT-vejledning - afsnit 4.1.2)
- Ikke-akutte anæstesitilsyn skal bestilles via mail AUHIntensiv-ECTforesporgsel@rm.dk. Svartid er inden for to hverdage. Er der brug for akut anæstesitilsyn, skal vagthavende anæstesilæge på Intensiv Nord kontaktes på 7846 4803.
- **OBS:** Se ECT-vejledning - afsnit 2.1 for Arbejdsgang ved forhåndstilkendegivelse af fravalg til genoplivning

4. Igangværende medicinsk behandling som skal pauseres/justeres inden opstart af ECT-behandling (ECT-vejledning - afsnit 5)

5. Øvrige ordinationer og opmærksomhedspunkter:

- **Måling af TOKS forud for hver ECT-behandling** (dagen før ECT og morgen på ECT-dagen kl. 6)
  - **Hvis BT >160/100mmHg:** tilkaldes lægen mhp. behandling af det forhøjede blodtryk, før patienten køres til ECT.
  - **Ved vedvarende forhøjet BT>160/100mmHg** på trods af relevant medicinsk behandling, bør ECT udskydes, medmindre der foreligger en lægefaglige vurdering om at ECT skal udføres (f.eks. i tilfælde af livstruende tilstande). I dette tilfælde skal ECT-anæstesiteam kontaktes, og informeres om problemstilling
- **Hydrering:** min. 1000ml væske dagen før ECT (særlig vigtigt hvis lithiumbehandling)
- **Diabetes:** ordiner måling blodsukker (BS) på ECT-dagene fra kl. 7 og 1x/time, indtil pt. bliver kørt til ECT (se bilag 3)

6. Opret standardplanen "Henvisning til ECT" og udfyld samtlige SFIer:

- Indikation ved unilateral og bilateral ECT (ECT-vejledning - afsnit 6).
- Kun speciallæger i psykiatri kan ordinere yderligere behandlinger samt ordinere skift fra unilateral til bilateral, hvis der er manglende klinisk effekt.

- Ordination af yderligere behandlinger eller ændringer af ordinationsform ordineres ligeledes i "Henvisning til ECT".
- Såfremt den ordinerende speciallæge ikke ønsker at patienten skiftes til bilateral behandling, noteres det under kommentar i standardplanen "Henvisning til ECT".

7. Booking – indlagte patienter:

- Indlagte patienter bliver booket af **sengesekretariatet**
- Som udgangspunkt får indlagte patienter tre ECT-behandlinger om ugen, fortrinsvis mandag, onsdag og fredag.
- Når en indlagt patient er henvist til ECT-serie, skal patienten tilføjes på en af de nedenstående lister i EPJ afhængigt af, hvilken prioritet patienten skal have:
  - Akutliste: ECT akut-liste – ADA Klinik for Depression – AUH
  - Elektivliste: ECT elektiv liste – ADA Klinik for Depression – AUH
  - Se nedenfor i forhold til kriterier for akut og elektiv ECT-behandling.

Trin for trin-guide til at tilføje til en patientliste:

1. Slå patienten op i EPJ
2. Tryk på ikonet patientlister (eller tryk alt+F9)
3. Tryk "Tilføj patient til patientliste..."
4. Søg en af de to ovenstående lister frem og tryk "OK"

- Der skal anføres i kommentarfeltet på patientlisten, om ordinationen er : 1. Opstart af ECT-serie 2. Fortsættelse af ECT-serie

- Det skal altid noteres på ECT-listen hvis patienten har diabetes eller i behandling med Lithium, for at sikre, at patienten får en tid til ECT-behandling så tidligt som muligt på dagen.

- En patient kan tilføjes ECT-listerne, når henvisningen er gyldig. Henvisninger der ligger som kladder bliver derfor ikke booket.

- Alle patienter starter op med ECT-behandling på det tidspunkt, de er booket på bookinglisten. I særlige tilfælde, hvis der f.eks. er for mange patienter på bookinglisten, vil akutte patienter dog blive prioriteret over elektive patienter. Status på ECT kan ses i Klinisk Logistik. 2.
- Der bliver automatisk booket 12 behandlinger i starten af ECT-forløb, selvom der bliver ordineret færre behandlinger. Det er derfor vigtigt at huske at:
  - Forny ordinationen, hvis patienten skal mere end de første ordinerede (f.eks. hvis der blev ordineret 6 behandlinger i starten, skal der laves ny ordination efter de første 6 behandlinger, selvom tiderne allerede er bookede)
  - Informere sengesekretariatet via patientlisten, hvis patienten ikke skal have flere behandlinger og de resterende behandlinger, ud af de 12, skal aflyses

Kontakt til ADA sengesekretariatet:

- Alle ændringer i patientens ECT-forløb skal kommunikeres via patientlisterne (akut- og elektivlisten) i EPJ, f.eks. ændring af interval mellem ECT-behandling, ophør af ECT-behandling (så de resterende behandlinger aflyses), m.m.
- Ved akutte ændringer kontaktes sengesekretariatet på telefon 78472100.
- Funktionspostkassen: ps.sekretariat.sengeafsnit@rm.dk

7.1 Kriterier for elektivliste og akutliste:

Akutlisten bliver brugt, hvis/når der er en klar indikation for hurtigt at iværksætte ECT-behandling pga. svær forpinthed, livsfare samt akut stor selvmordsrisiko. Det kan f.eks. være:

- Svær depression med akut øget selvmordsrisiko
- Svær depression med psykotiske symptomer med udtalt forpinthed, hvor der er behov for en hurtig indsats.
- Stupor og katatoni.
- Delirium hvor anden behandling ikke virker.
- Maniske tilstande/blandingstilstande med begyndende delir eller med psykotiske symptomer, hvor medicinsk behandling ikke har virket, eller hvor der er behov for en hurtig indsats.
- Skizofreni med udtalte psykotiske symptomer og forpinthed eller agitation, hvor farmakoterapi ikke kan optimeres, eller hvor der er behov for en hurtig indsats.
- Malignt neuroleptikasyndrom.

Elektivlisten bliver brugt til patienter, som ikke opfylder kriterierne for at stå på akutlisten (f.eks. fordi de ikke er i livsfare), men som stadig har behov for ECT-behandling. Det kan f.eks. være:

- Patienter med svær depression uden eller evt. med diskrete psykotiske symptomer.
- Patienter med moderat til svær depression hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømt (enten pga. manglende respons, uholdbare bivirkninger eller somatisk sygdom)
- Patienter med moderat til svær depression, som tidligere har vist god respons på ECT.
- Mani/blandingstilstand, hvor intensivering af den medicinske behandling er mulig.
- Skizofreni, hvor intensivering af den medicinske behandling er mulig.

Hvis der er ventetiden op til den første ECT-behandling bør andre behandlingstiltag sættes i gang og intensiveres, f.eks. medicinsk behandling og/eller TMS.

7.2 Særligt ift. en bloc behandling:

- Kriterierne for akut en bloc ECT-behandling er akutte livstruende psykiatriske tilstande uanset ætiologi, det vil sige hvad enten de forårsages af somatiske eller psykiske forhold.
- Ved en bloc ECT-behandling bliver behandlingen givet tre dage i træk, med bilateral elektrodeplacering og strømdosis lige med alder.
- En bloc ECT-behandling skal gerne begynde mandag, tirsdag eller onsdag. Ved behov for en bloc tirsdag, lørdag samt søn- og helligdage skal det aftales med cheflæge Farahna Harees, idet behandlingen kræver særlig aftale med anæstesien.

En bloc ECT-behandling på dage, hvor der ikke er planlagt ECT:
Hvis der skal gives ECT tirsdag, i weekender eller helligdage, skal det godkendes af cheflæge Farahna Harees (telefon 2325 8288). Arbejdsgang:

1. Den ordinerende læge kontakter cheflæge Farahna Harees med henblik på at få godkendelse af en bloc ECT-behandling.
2. Efter godkendelse fra cheflæge Farahna orienterer den læge eller plejepersonale ECT-klinikken om, at der er en bloc ECT-behandling. ECT-klinikken kan kontaktes på telefon 2013 8836 eller 2013 4929.
3. ECT-klinikken arrangerer behandlingstidspunktet, de orienterer sengeafsnittet og koordinerer med anæstesien
4. En bloc ECT-behandling i weekender eller helligdage OG en bloc ECT-behandling på tirsdage til patienter indlagt i BUA, RET samt somatiske afdelinger: Den ordinerende læge orienterer vagtholdet om den forestående en bloc ECT-behandling. Bagvagten udpeger en forvagt, som kan forestå ECT-behandlingen. En bloc ECT-behandling på

tirsdage til patienter indlagt i ADA eller AFP: Det er den afdeling, der har patienten indlagt, der sørger for en læge til at forestå ECT-behandlingen.

7.3 ECT til patienter med organisk delerium:

Cheflæge Farahna Harees konfererer med anæstesien i forhold til godkendelse af ECT behandling til somatiske patienter.
Anæstesi til ECT hos patienter med delir på Intensiv Nord og Øst skal forestås af anæstesilæger fra Intensiv Nord.
Psykiateren kontakter anæstesien på telefon 7846 4803 for planlægning af dette. Særligt for Intensiv Øst patienter, så er dette et samarbejde med læger fra Intensiv Øst, men læger fra Intensiv Nord forestår behandlingen.

Retningslinje angående, hvordan det kan vurderes, om patienten er i delir, kan ses her: Delirium, identifikation, forebyggelse, behandling og pleje, regional retningslinje

7.4 Særligt ift. booking af ambulante patienter som indlægges til vedligeholdelses ECT

Hvis en patient med forløb i en ambulant klinik ikke opfylder alle kriterier for, at vedligeholdelses ECT-behandlingen kan foregå ambulant (ECT-vejledningen bilag 2), skal patienten indlægges forud for hver ECT-behandling.

I ECT-henvisningen til vedligeholdelses ECT-behandling skal der noteres frekvens for ECT, antal af ordinerede ECT-behandlinger og samlet antal af ECT-behandlinger. Hvis patienten henvises til vedligeholdelses ECT-behandlingen efter en afsluttet akut ECT-serie, bør antallet af behandlinger, der er modtaget under den akutte ECT-serie, ikke medregnes i SFI-en ”antal behandlinger i alt i serien”.

Når henvisningen er gyldig, tilføjes patienten til patientlisten ”Elektiv ECT-liste”. Der skal noteres frekvensen for ECT-behandlinger, og om patienten har diabetes eller er i behandling med lithium.

Sengeafsnittet planlægger indlæggelsen med patientens primærbehandler og ADA sengesekretariatet booker patienten til ECT-behandling (ikke ECT-enheden).

Ændringer til behandlinger (f.eks. ny ordination, ændringer i frekvensen af ECT-behandlinger, eller stop af ECT-behandling) kommunikeres til ADA sengesekretariatet via elektivlisten.

7.5 Særligt ift. godkendelse af vedligeholdelsesbehandling

V-ECT skal godkendes af ECT-ansvarlige speciallæger ved opstart og ved ønske om fortsættelse hver 3. måned. Drøftelse foregår ved at kontakte ECT-ansvarlige via Funktionspostkasse (psy.auhp.ect-tms.ansvarlige.forespoergsel@rm.dk), hvor det skal fremgå, på hvilket grundlag man ønsker at ordinere vedligeholdelsesbehandling, herunder info om diagnose, kort sygehistorie og indikation for v-ECT, samt hvordan patienten tålte den akutte ECT-serie. Ved godkendelse hver 3.måned, skal man skrive, om der fortsat er god effekt, og om behandlingen tåles godt.

Indlagte patienter der skal modtage ECT-behandling

Vurdér typen af behandling

- Elektiv
- Akut
- En bloc – Cheflæge Farahna Harees kontaktes, og efterfølgende kontaktes ECT-enheden, som booker behandlingen

Før henvisning til ECT

I ugen inden henvisningen:

- Ordiner relevante ratings før opstart af ECT (baseline) samt under ECT-forløbet (ECT-vejledning afsnit 9)
- Se ECT vejledningen bilag 1, herunder forundersøgelser, pausering/justering af medicinsk behandling, ordination af TOKS

Henvis til behandling

- Lav henvisning i EPJ, og sæt patienten på den relevante patientliste (akut- eller elektiv)
- Når patienten er booket af sekretæren, fremgår det på patientens Klinisk Logistik
- Der bliver booket 12 behandlinger ved opstart. Ved 6. behandling står i bookingen, at der skal ordineres 6 yderligere behandlinger.
- Notér på akut- eller elektivlisten, hvis patienten har diabetes eller i behandling med lithium

Under ECT

- Ændringer til behandlingen, fx ny ordination, ændring af interval, overgang fra indlagt til ambulant eller stop af ECT-behandling sættes på akut- eller elektivlisten. Ved akutte ændringer kontaktes sengesekretariatet på 7847 2100
- Der skal laves relevante ratings (afsnit 9 ECT vejledning)
- Ordination af flere end 18 ECT-behandlinger skal godkendes af ECT-ansvarlig overlæge eller stedfortræder.

Efter endt ECT-serie

- Senest 4 uger efter endt serie skal der igen foretages ratings
- Ratingresultater overgår automatisk til ECT-grafen, så graden af effekt kan blive vurderet

Ambulante patienter der indlægges til vedligeholdelses ECT-behandling

Vurdér typen af behandling

- Hvis patienter med forløb i en ambulant klinik ikke opfylder alle kriterier for at ECT-behandlingen kan foregå ambulant (ECT-vejledningen bilag 2), skal patienten indlægges forud for hver ECT-behandling

Ordinér ECT

- Se ECT-vejledning bilag 1, herunder forundersøgelser, pausering/justering af medicinsk behandling, ordination af TOKS
- Primær behandler/læge laver relevante ratings før opstart af ECT-behandling (baseline), samt under ECT-forløb (ECT-vejledning, afsnit 9)

Henvis til behandling

- Lav henvisning i EPJ
  - Noter frekvens for ECT, antal behandlinger, om det er akut-serie eller vedligeholdelses ECT
- Føj patienten til relevant patientliste, akut- eller elektivlisten (noter frekvensen for behandlingen og hvis har diabetes eller er i behandling med lithium)
- Sengeafsnittet planlægger indlæggelsen med patientens faste behandler.
- ADA sengesekretariat booker patienten til ECT-behandling
- Vedligeholdelses ECT-behandling skal godkendes af ECT-ansvarlige speciallæge ved opstart og ved ønske om fortsættelse hver 3. måned (ECT-vejledningen afsnit 2,4)

Patienten møder ind i sengeafsnittet

- Patienten møder ind som aftalt på sengeafsnittet og faster efter gældende regler
- Patienten fremgår af ECT's prioriteringsliste, og ECT-enheden ringer med tid til sengeafsnittet
- Ændringer til behandlingen, fx ny ordination, ændring af interval, overgang fra indlagt til ambulant eller stop af ECT-behandling sættes på akut- eller elektivlisten. Ved akutte ændringer kontaktes sengesekretariatet på 7847 2100

Efter endt ECT-serie

- Efter ECT-behandling kommer patienten tilbage i sengeafsnittet.
- Patienten udskrives på dagen eller efter aftale
- OBS på løbende opfølgning til ambulatoriet
- Senest 4 uger efter endt serie foretages ratings igen
- Ratingresultater overgår automatisk til ECT-grafen, så graden af effekt kan vurderes